تعقدٍ فرق في مستشفيات كثيرة اجتماعًا قصيرًا عن سلامة المرضى.

وفي تجربة بأربعة مستشفيات جامعية، انخفض معدل الأحداث الضارة، أي الأضرار التي تسببها الرعاية نفسها، بنسبة 12%.

لكن كثيرًا من هذه الاجتماعات لا يُعقد كما خُطّط له. وهذا ما وجدته خمس دراسات نُشرت بين عامي 2021 و2026.

← اسحب للمتابعة

الفكرة

ما الاجتماع القصير للسلامة؟

هو اجتماع قصير ومنظم، يكون يوميًا في الغالب. يذكر فيه الفريق ما قد يؤذي المرضى، ويتفق على ما سيفعله لمنعه.

والحدث الضار ضرر تسببه الرعاية نفسها، لا المرض.

تجربة تورونتو

شملت التجربة أربعة مستشفيات جامعية، والأطباء وحدهم

12%

هي نسبة انخفاض معدل الأحداث الضارة بعد أن بدأ الأطباء الاجتماعات، بحسب مراجعة ملفات 912 مريضًا.

64%

من إجابات الأطباء كانت إيجابية في أسئلة الاستبيان الخاصة بالحديث عن الأخطاء، بعد أن كانت 36%.

ولم يكن حضور الأطباء كاملًا، فقد تراوح بين 30% و85% بحسب المستشفى.

Guo et al., BMJ Qual Saf, 2025

كثيرًا ما يُعقد الاجتماع ناقصًا

64

هو عدد الأجنحة التي استمرت فيها الاجتماعات، من أصل 92 جناحًا في خمسة مستشفيات.

4.9

هو متوسط ما تضمّنه الاجتماع الواحد من 9 عناصر يُفترض أن يشملها.

وكانت الفرق تُغفل عادةً أمرين: عرض رسم بياني يبيّن الأضرار مع مرور الوقت، ومراجعة ما وقع منها سابقًا.

Lamming et al., BMC Health Serv Res, 2021

من يحضر؟

في العناية المركزة البريطانية، يحضر الممرضون بانتظام، أما الأطباء فحضورهم أقل بكثير

في استبيان أجابت عنه 74 وحدة عناية مركزة بريطانية، قالت 71 منها إنها تعقد هذه الاجتماعات.

89% أفادت 63 وحدة بأن الممرضين يحضرون بانتظام.

32% ولم تُفِد بذلك عن الأطباء إلا 8 وحدات.

النسبتان محسوبتان من أعداد مختلفة من الوحدات التي أجابت.

وذكرت الوحدات عيوبًا: يأخذ الاجتماع وقتًا، وقد يبدو بلا فائدة، وقد يقطع رعاية المرضى، وقد يغيب فيه الأمان النفسي، أي شعور العاملين بأنهم يستطيعون الحديث عن الخطأ دون خوف.

في تايوان، حُلّت كل المشكلات التي طُرحت في الاجتماعات

في جناح للأمراض الباطنية، طُرحت 81 مشكلة في 44 اجتماعًا، وحُلّ أكثرها خلال ساعات.

ويُرجّح الكاتب، استنتاجًا من الدراسات الخمس، أن الاجتماع ينفع حين يحضره من يملك القرار، ويُطرح فيه الخطر دون خوف، ويُتابَع ما يُتفق عليه حتى يُنفّذ.

هذا استنتاج لم تقسه الدراسات.

ما يستنتجه الكاتب من الدراسات

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

يحدد للاجتماع هدفًا واضحًا: ما الذي قد يؤذي المرضى اليوم، وماذا سنفعل لمنعه؟

2

ويحرص على حضور الأطباء وسائر المهن، لا الممرضين وحدهم.

3

ويقيس أمرين: هل يُعقد الاجتماع كاملًا، وهل تقلّ الأضرار.

الخطوة 3 استنتاج من الكاتب، لا نتيجة مختبرة.

> **بعد ثلاث سنوات، أتريد أن يكون اجتماع فريقك موعدًا يُنسى ما قيل فيه، أم مكانًا تُكتشف فيه المخاطر ويُتفق على ما يمنعها؟**

حدود هذه الأدلة

أُجريت تجربة تورونتو في أربعة مستشفيات جامعية، وشملت الأطباء وحدهم.

ولم تقارن دراستا كوريا الجنوبية وتايوان نتائجهما بأجنحة لم تعقد الاجتماعات، والاستبيانات تقيس آراء العاملين لا الأضرار نفسها.

ولم تُجرَ أيٌّ من الدراسات الخمس في مستشفى عربي، ونفع الفكرة في قطاعات أخرى استنتاج لم يُختبر بعد.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Guo, M.-Q., et al. (2025). Impact of medical safety huddles on patient safety: a stepped-wedge cluster randomised study. *BMJ Qual Saf*, 35(5), 326–333.

[2] Lamming, L., et al. (2021). Fidelity and the impact of patient safety huddles on teamwork and safety culture (HUSH). *BMC Health Serv Res*, 21, 1038.

[3] Stayt, L., et al. (2026). Safety huddles in ICUs across the United Kingdom: a national e-survey. *Intensive Crit Care Nurs*, 96, 104470.

[4] Lee, S. E., et al. (2023). A safety huddle intervention in in-patient surgical units. *J Nurs Manag*, 2023, 8929993.

[5] Lin, S.-P., et al. (2022). The effectiveness of multidisciplinary team huddles in a hospital setting. *J Multidiscip Healthc*, 15, 2241–2247.

المقال الكامل: tamayuz10x.com/article-oe-evidence-daily-safety-huddles.html